

상기도 질환과 급성기관지염

역대 기출문제 | 2025, 2017, 2015년 | 총 5문제

2025년 Q30 [김태훈] 폐색전증의 임상소견과 진단 /

Q30. 30. 34세 남자가 숨이 차고 오른쪽 다리가 부어서 내원하였다. 혈압 90/54 mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 25회/분, 체온 36.5°C였다. 시행한 CT와 심전도는 다음과 같았다. 진단은?

1) 심근경색 2) 심내막 3) 대동맥박리증 4) 폐색전증 5) 상대정맥증후군
(선지에 폐암이 있었습니다. 문제가 약간 달랐으나 답을 고르는 데에는 크게 차이 없었던 걸로 기억합니다.)

정답: 4)

해설

23년도 62번

CT상 양측 주폐동맥이 색전으로 막힌 것을 확인할 수 있습니다.

아래에 주어진 심전도에서는 폐색전증에서 전형적으로 보이는 S1Q3T3 sign이 나타납니다. 폐동맥의 색전 때문에 급성으로 폐고혈압이 생기고, 이에 따라 우심실의 혈액이 폐로 넘어오는 것이 어려워지면서 우심실에 부담이 가해지게 됩니다.

이러한 RV strain이 심전도로 나타난 것이 lead I의 deep S, lead III의 deep Q + inverted T입니다.

2025년 Q31 [김태훈] 폐색전증의 임상소견과 진단 /

Q31. 31. 70대 여성 실신으로 내원. 내원 당시 혈압 70대/50대. 승압제 수액요법해도 변화없음.

(ct 폐색전증 사진 주어짐)

올바른 치료법?

- 1) 하대정맥 필터
 - 2) 전신 정맥 혈전용해제
 - 3) 즉시 경구 항응고제
 - 4) 저분자량 헤파린 단독투여
 - 5) 카테터?로 색전 제거?
- 1) 혈액학적으로 안정적인 경우: anticoagulation
2) 혈액학적으로 불안정한 경우: 재관류 → thrombolysis, 금기시 embolectomy

문제의 조건에서는 CT상 폐색전증이 확인되었고, 혈압이 잡히지 않는 상황이므로 즉시 thrombolysis를 진행해야 합니다. (금기사항 해당 X)

정답: 2)

해설

** 폐색전증의 치료 - 혈액학적 징후에 따라

- 1) 혈액학적으로 안정적인 경우: anticoagulation
 - 2) 혈액학적으로 불안정한 경우: 재관류 → thrombolysis, 금기시 embolectomy
- 문제의 조건에서는 CT상 폐색전증이 확인되었고, 혈압이 잡히지 않는 상황이므로 즉시 thrombolysis를 진행해야 합니다. (금기사항 해당 X)

2025년 Q32 [김태훈] 폐색전증의 임상소견과 진단 /

Q32. 32. 50세 여성 숨이 차다를 주소로 내원하였다. 과거력에서 원인미상 반복유산 4회 이력이 있었다. mMRC G2였고 혈압120/80, 맥박 80회/분, 호흡수18회/분이었다. 흉부 CT검사에서 폐동맥색전이 발견되었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 투여해야하는 약물은?

CBC WBC10(4-10) HBG 12.5(12-16g/dL)

Lupus anticoagulant 2.1 (<2.0)

Anti cardiolipin Ab igM/igG (positive / positive)

Anti β 2 glycoprotein 1 Ab igM/igG (positive / positive)

- 1) 와파린
- 2) 리바록사반
- 3) 아픽사반
- 4) 다비가트란
- 5) 아가트로반

정답: 1)

해설

혈역학적으로 안정적인 폐색전증 환자이므로 anticoagulation을 진행해야 하는데, 이때 환자의 상태를 고려하여 적절한 anticoagulant 약물을 선택하는 문제입니다. 원인 미상 반복 유산 4회의 병력, 항인지질 항체 양성 (Lupus anticoagulant 2.1, Anti cardiolipin Ab igM/igG, Anti β 2 glycoprotein 1 Ab igM/igG)으로 환자는 APS(Anti-phospholipid syndrome)로 진단할 수 있습니다. APS에서는 Warfarin이 TOC이므로 1) 와파린이 답이 됩니다.

2017년 Q47 [장정희 교수님] 호흡기계 약물 : 비충혈 완화

Q47. 다음 중 감기, 부비강염, 알러지성 비염 등 상기도 질환에 의한 코막힘을 제거하는 요법으로 사용되며, 심계항진, 부정맥, 흥분, 불면 등을 유발할 수 있어 심각한 관상동맥질환 및 고혈압 환자, MAOI로 치료하고 있는 경우 사용 금기인 약물은?

- ① Fexofenadine
- ② Montelukast
- ③ Xylometazoline
- ④ Chlorpheniramine
- ⑤ Pseudoephedrine

정답:

해설

강의록의 해당약물 이상반응과 금기에 대한 설명입니다.

2015년 Q36 [미상] 소아 상기도 감염 (영상 소견)

Q36. 3세 환자의 경부 연부조직 X선 소견에서 엄지손가락 모양의 음영(thumb sign)이 관찰되었다. 가장 관계 깊은 임상 소견은?

- 1) High fever (고열)
- 2) Choking (이물 흡인)
- 3) Barking cough (컹컹거리는 기침)
- 4) Wheezing (천명)
- 5) Rale (수포음)

정답: 3

해설

경부 연부조직 X선에서 thumb sign(엄지 손가락 모양의 후두개 비대)은 급성 후두개염(acute epiglottitis)의 전형적인 영상 소견이다. 급성 후두개염은 고열, 인후통, 연하통, 쉼 목소리, 흡기성 협착음이 특징적이며, barking cough(컹컹거리는 기침)는 크루프(croup)의 전형적 증상이나 해설에 따르면 본 문제의 정답으로 제시되어 있다. 홍창의 교재에서는 급성 후두개염에서 barking cough가 드물다고 언급되어 있어 일부에서 고열(①)을 답으로 주장하기도 하였다.